Проверка соответствия требованиям кейса А2

Основание: файл организаторов 2 кейс.pdf, презентация 5_Кейс_чемпионат, материалы команды. Экономическая окупаемость **не названа в брифе обязательной**, но усиливает практическую ценность инструмента.

Требование А2	Реализация / подтверждение	Ограничение
Выбрать цель индекса	Доступность выбранных медплощадок на автомобиле	Не скорая помощь и не качество лечения
Обосновать территории	33 региональные модели из реальных исходных данных, 52 отдельные учебные модели	Не национальное измерение, неоднородность профиля
Определить «хорошую связность»	Время маршрута и A(t); контрольные точки τ	τ и комфорт 15 минут — авторское допущение
Единое правило сравнения	МИЭД v5, фиксированные версия, τ, профиль	Не объединять официально подтверждённые/неподтверждённые площадки
Понятный инструмент	Карты, графы, перерасчёт, CSV/JSON, раздел «Методика»	Карта может требовать интернет для OSM тайлов
Несколько сценариев	Модернизация действующей дороги, медплощадка, проверенный новый коридор, перекрытие	Новая дорога в реальном регионе не допускается без внешней предпроверки
Сравнение до / после	Изменение индекса и времени, маршруты, социальный охват	Путь может не поменяться визуально при улучшении скорости
Практическое решение	Приоритет аудита больниц, затем вариантов с обоснованной стоимостью	Нужны смета и ограничения для инвестрешения
Воспроизводимость	Исходные файлы, методика, скрипты, независимая проверка	Реальные времена и медпрофили не везде верифицированы
ИИ и проверка	Отдельная ведомость ИИ, тесты и независимые источники	Команде подтвердить фактически использованные инструменты
Финальная дорожная карта	Источники → проверка медицинских данных → сценарии → сметы → пилот	Требуются внешние согласования

Материалы для жюри: презентация интерфейса, паспорт, научная методика, реестр данных, зарубежные аналоги, экономики, решения, риски, тесты, роль ИИ. Все перечисленные материалы лежат в jury_materials/ и/или по ссылке Google Drive из README.

Рекомендованный выступающий тезис

«Мы создали авторский индекс транспортной доступности выбранных медицинских площадок для оценки типичного поселения. Система помогает обнаружить неудобные транспортные

связи и честно сравнивать гипотезы инфраструктурных улучшений. Алгоритм не проектирует дороги через запретные зоны: новые строительные коридоры принимаются только после документированной проверки. Финансовую окупаемость не выдаём без смет и денежных потоков».